

Сценарій № 2

Ви лікар приймального відділення дитячої клінічної лікарні.

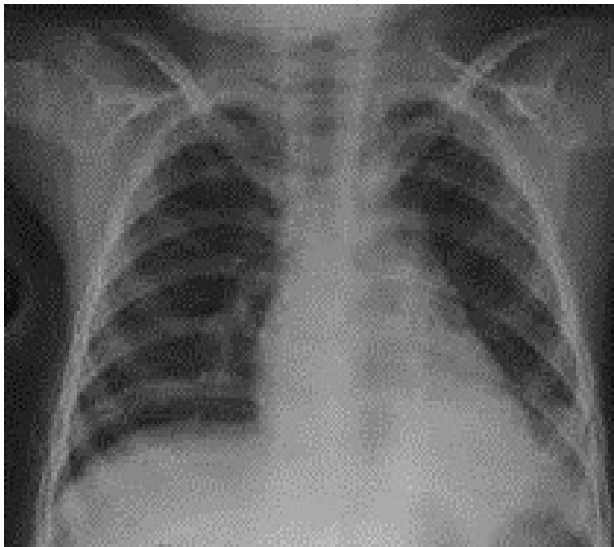
До Вас звернулася мати хлопчика 7-ти років зі скаргами на напад задухи, затруднення видиху, малопродуктивний кашель.

Із анамнеза відомо, щ одитина хворіє на бронхіальну астму протягом 2-х років, напад виник після контакту з кошеням.

В анамнезі життя – ГРВІ 3 рази на рік, atopічні реакції на цвітіння амброзії та інші інгалаційні антигени.

Об'єктивно: стан дитини середньої тяжкості, що обумовлено синдромом бронхіальної обструкції та дихальної недостатності. Перкуторно над легеньми: тимпанічний відтінок перкуторного звука. При аускультції – дихання проводиться над всією поверхнею легень, помірно послаблене, вислуховуються сухі свистячі хрипи з обох боків, подовжений видих. ЧД 26/хв. Сатурація 96%. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тонисерця ясні, ритмічні, ЧСС 85 уд/хв. Живіт м'який, безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Фізіологічні відправлення без особливостей.

Показник	Дані пацієнта	Нормативні значення
Гемоглобін, г/л	140	110-140
Еритроцити, 10^{12} /л	4,9	3,7-4,9
Кольоровий показник, од	0,9	0,8-1,0
Тромбоцити, 10^9 /л	230	150 – 400
Лейкоцити, 10^9 /л	7,8	5-10
Паличкоядерні нейтрофіли, %	4	0,5-5
Сегментоядерні нейтрофіли, %	46	25-60
Лімфоцити, %	34	26-60
Еозинофіли, %	10	1-5
Моноцити, %	6	2-10
ШОЕ, мм/год	13	4-12



Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановити контакт з пацієнтом та батьками/опікунами (привітатись,	Сказати

	представитися, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт	Доброго дня. Я лікар педіатр.
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного обстеження дитини	Сказати Чи даєте Ви свою згоду на проведення клінічного обстеження Вашої дитини (Будемо вважати що згода отримана)
2.Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнта (зі слів батьків/опікунів)	Сказати: Скільки років дитині? Очікувана відповідь: 7 років Сказати: Які скарги у дитини? Очікувана відповідь: скарги на напад задухи, затруднення видиху, малопродуктивний кашель.
2.2	Анамнез захворювання	Сказати: Як довго хворіє дитина? Очікувана відповідь: Хворіє 2 роки, коли виник напад після контакту з кошеням.
2.3	Анамнез життя	На які захворювання дитина хворіла? Алергія? Травми, операції? Спадковість? Щеплення?
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавички та	Виконати/сказати Будемо вважати, що руки оброблені
3.2	Оцінити загальний стан пацієнта	стан дитини середньо тяжкий, що обумовлено бронхообструктивним синдромом та дихальною недостатністю.
3.3	Обстеження дихальної системи	Перкуторно над легеньми: тимпанічний відтінок перкуторного звуку. При аускультатії – дихання проводиться над всією поверхнею легень, помірно послаблене, вислуховуються сухі свистячі хрипи з обох боків, подовжений видх. ЧД 26/хв.
4.Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного аналізу крові	Сказати: еозинофілія
4.2	Визначити результат рентгенологічного дослідження органів грудної клітки	Сказати: рентгенологічні ознаки Еміземи легень, горизонтальне стояння ребер, що є характерним для бронхіальної астми в стадії Загострення.
4.3	Визначити провідний синдром	Сказати: синдром бронхіальної

		обструкції та дихальної недостатності
4.4	Встановити клінічний діагноз	БА, атопічна форма, інтермітуючий перебіг, період загострення середнього ступеня важкості, ДН 1 ст.
5. Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення пацієнта	госпіталізація в стаціонар у пульмонологічне відділення, призначення інгаляційних бронходилататорів – б2 агоністів короткої дії, інгаляційних глюкокортикостероїдів. (будесонід 500 мкг 2 р в день)
6. Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	раціональне харчування, загартовування, санація вогнищ хронічної інфекції, зменшення контакту з побутовими антигенами та антигенами тварин. Консультація алерголога. Навчання пацієнта.
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнта/батьків/опікунів про можливі ризики та етичні аспекти	Ви повинні знати про можливі ускладнення БА – астматичний статус.